

		(Imc 44.64)	
INDICADO POR: Dr. Felipe			
☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
NS			
RONALD PEREIRA DUTRA			
IDADE: 50	PESO: 117	ALTURA: 168	PROFISSÃO:
SINTOMAS: sonolência / aurota engarrafado (raro) respiração forte.			
QUEIXAS: acordar e perder os sons.			
MEDICAMENTOS:			
Obexil			
MÉDICO: Dr. Felipe Fortes			
MARCAPASSO: ☐ S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ☐ S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada 50' → 2x semana			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:
HORA QUE DORME: 21	HORA QUE ACORDA: 3:30		
COCHILHO ☒ S ☐ N	DORME ACOMPANHADO: ☒ S ☐ N ☐ EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: ☐ S ☒ N	DORMEM NO QUARTO: ☐ S ☒ N		PET NO QUARTO: ☐ S ☒ N
BEBIDA ALCOÓLICA: ☐ S ☐ X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: ☐ S ☐ MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 4		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 26,1	SPO2: 86%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sinusite (polipos)			
CIRURGIAS: ☐ NASAL ☐ AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: ☒ RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA ☒ CARDÍACA			
☒ ORTOPÉDICA		☒ NEUROLÓGICA ☐ OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☐ S ☐ N		SPO2 C/ CPAP: —	PRESSÃO NO EXAME: —
16/04/25 - Avaliação Auto 5 a 30 cmH2O.			
23/04/25 P= 7,3 cmH2O P95: 9,5 cmH2O			
IAH= 1,2elh		ali dia 21/04	
muco= 5h13			
fuga= 3elmin			
Apertar aca 22/04 PFixA: 7,4 cmH2O / IAH= 0,7elh			
		muco= 5h11 min	
		fuga= 8elmin	
30/04/25 P= 7,4 cmH2O			
IAH= 0,7elh		sentiu bem	
muco= 5h45 min		seu	
fuga= 0,7elmin.		+ P. 7,2 cmH2O	

06/05
25 $P=7,2 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH=0,7 \text{ e/h}$
mdc uso: 5h42'
fuso: 1,2 l/m

Relata estar bem adaptado
ao CPAP porém tem dificuldade
de manter o sono

Oriento rotina de higiene do
sono e diário do sono

Natasha

27/05
25 $P=7,2 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH=0,7 \text{ e/h}$
mdc uso: 4h49'
fuso: 5,7 l/m

Dificuldade em ir
mais cedo para cama
Reforço rotina de higiene do
sono e atividade física

Natasha

08/07
25 $P=7,2 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH=0,8 \text{ e/h}$
mdc uso: 4h53'
fuso: 6,2 l/m

Relata dificuldade na
rotina do sono

Natasha

Nome: RONALD PEREIRA DUTRA

Data de Nascimento: 8-11-1974

IMC: 44,64

Sexo: Masculino

Data do exame: 13-04-2024

Peso: 126 kg

Altura: 1,68 m

Médico: DRA. MARIANA REIS MURIN

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 13-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 550,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 129,5 e 81,5 minutos. O tempo total de sono foi de 349,5 min, eficiência de 63,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,4%; estágio N2: 60,9%; estágio N3: 20,2%; sono REM: 14,4%. O índice de despertares foi de 14,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,1/hora, sendo 15 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 105 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 86%, permanecendo 1,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 90 bpm e NREM de 53 - 89 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 26,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=86%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

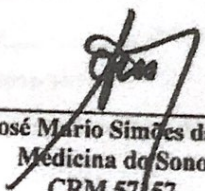
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57